



Diário Clínico

Consulta Externa

22-Ago-2024 Dr(a). Ricardo M. Valente (HUC-PNEUMOLOGIA)

AP: asma persistente moderada, rinite alérgica a ácaros; hipotireoidismo autoimune sob substituição. Alergia a ibuprofeno, com broncospasmo prévio.

Consulta de vigilância. Controlo global parcial. Dispneia/"pieira" episódicas, sobretudo com exposição a pó, variações térmicas e IVAS; necessidade de broncodilatador de alívio ocasional, habitualmente 1-2x/semana. Sem recurso a SU, corticoterapia sistémica ou antibioterapia por intercorrência respiratória desde última observação. Nega limitação relevante nas AVD; sem despertares nocturnos frequentes, apenas episódios isolados. Sem tosse produtiva, febre, dor torácica ou hemoptises. Sinusite aguda em 10/2024, tratada ambulatorio, resolução clínica completa; sem recorrência de rinorreia purulenta ou dor facial.

MH: budesonido/formoterol 200/6, 2 inh 2id; montelucaste 10 mg à noite. Refere adesão globalmente boa, embora reconheça omissões esporádicas da dose nocturna. Técnica inalatória revista: inicialmente inspiração algo rápida e apneia pós-inspiração insuficiente; corrigida em consulta, reforçados expiração prévia, inspiração lenta/profunda, apneia 8-10 seg e lavagem oral após CI.

EO: apirética, TA 116/72 mmHg, FC 76 bpm, SpO2 98% ar ambiente. Eupneica em repouso, sem uso de musculatura acessória. AP: MV bilateralmente presente, discretamente diminuído em expiração forçada; sem sibilos audíveis no momento, sem crepitações. Sem edemas periféricos.

Espirometria de controlo realizada em condições tecnicamente aceitáveis, curvas fluxo-volume reproduzíveis, sem artefactos significativos. Pré-broncodilatador: CVF 3,62 L, 96% previsto; VEMS 2,53 L, 80% previsto; índice VEMS/CVF 69,9%, abaixo LLN, compatível com obstrução ligeira. Fluxos expiratórios médios reduzidos, FEF25-75 1,72 L/s, 52% previsto, sugerindo envolvimento de pequenas vias aéreas. Após broncodilatador: VEMS 2,86 L, incremento de 330 mL e 13%; CVF 3,74 L, incremento 120 mL; índice VEMS/CVF 76,5%. Resposta broncodilatadora positiva, com reversibilidade significativa da limitação ao fluxo aéreo. Comparativamente a estudo de 08/2024, sem alteração funcional significativa: VEMS pré-BD então 2,49 L e CVF 3,59 L, mantendo padrão obstrutivo ligeiro e reversível. Sem evidência espirométrica de restrição.

Asma sem exacerbação atual, controlo parcial, função respiratória estável. Manter budesonido/formoterol 200/6, 2 inh 2id e montelucaste 10 mg nocte; broncodilatador de alívio SOS conforme plano previamente instituído. Reforçadas evicção alérgica, adesão e técnica inalatória. Reavaliação em 6 meses com espirometria; antecipar se agravamento clínico, aumento de SABA ou sintomas nocturnos.



Diário Clínico

Consulta Externa

05-Set-2024 Dr(a). Inês Matos (HUC-NEUROLOGIA)

Seguimento por enxaqueca c/aura. AP: asma persistente moderada, tiroidite de Hashimoto sob substituição. Mantém ~2 crises/mês, sem aumento de frequência/intensidade face a consulta anterior. Aura visual estereotipada, escotoma cintilante/linhas luminosas de instalação gradual, duração ~20-30 min, seguida de cefaleia hemicraniana pulsátil, habitual predomínio direito, foto/fonofobia e náusea ligeira ocasional. Sem défice motor, disartria, diplopia, alteração persistente da sensibilidade, síncope ou alteração do estado de consciência. Sem cefaleia em trovoada, despertar nocturno recorrente por dor, febre, perda ponderal ou modificação recente do padrão álgico.

Topiramato 50 mg 2id, adesão referida como boa. Irritabilidade episódica e ligeira dificuldade de concentração, toleráveis; sem humor depressivo, ideação autolesiva, parestesias significativas ou litíase conhecida. Sumatriptano 50 mg SOS com alívio consistente se toma no início da fase algésica, habitualmente 1 comp/crise; sem necessidade de repetição na maioria dos episódios. Sem sobreuso de triptano/analgésicos. Mantém sono irregular em alguns períodos, reconhece associação com crises.

EO: TA 112/70 mmHg, FC 74 bpm, SatO₂ 99% AA, T 36,4°C. Vigil, colaborante, discurso fluente. Fundoscopia sem edema papilar. Pares cranianos sem alterações; campos visuais por confrontação conservados. Força 5/5 global, tônus e coordenação normais, sem dismetria. ROTs simétricos, cutâneo-plantar flexor bilateral. Marcha autónoma, sem ataxia; Romberg negativo.

RMN-CE 14/03/2024, protocolo encefálico c/ sequências T1, T2, FLAIR, DWI e SWI: morfologia e sinal do parênquima cerebral preservados. Sem lesões focais supratentoriais ou infratentoriais, sem restrição à difusão e sem evidência de produtos hemáticos. Sistema ventricular de dimensões normais, sem efeito de massa ou desvio da linha média. Região selar, junção crânio-cervical e vasos intracranianos de calibre habitual nas sequências disponíveis. Sem alterações estruturais justificativas de cefaleia secundária.

Manter topiramato 50 mg 2id, por benefício clínico superior aos efeitos adversos actuais; reavaliar se agravamento cognitivo/afectivo. Manter sumatriptano 50 mg ao início da cefaleia, podendo repetir 1x após 2 h se necessário; máximo 2 tomas/24 h e evitar uso >8-10 dias/mês. Reforçado diário de crises/aura, fármacos de resgate, sono, ciclo menstrual e possíveis desencadeantes. Sinais de alarme e recurso urgente explicados. Reavaliação em 6 meses.

20-Set-2024 Dr(a). Inês Valente (HUC-ENDOCRINOLOGIA)

Seguimento por tiroidite de Hashimoto/hipotiroidismo primário. Sem queixas sugestivas de disfunção tiroideia: nega astenia marcada, intolerância térmica, obstipação, palpitações,



Diário Clínico

Consulta Externa

tremor, alteração ponderal significativa ou alterações do trânsito intestinal. Sem disfagia, disfonia, sensação de corpo estranho cervical ou crescimento cervical percebido.

AP: asma persistente moderada; enxaqueca com aura; hipotireoidismo autoimune. MH: levotiroxina 50 mcg id, em jejum, boa adesão referida; sem tomas concomitantes de ferro/cálcio. Mantém restante terapêutica habitual.

EO: TA 116/72 mmHg, FC 74 bpm, SatO₂ 99% AA, T 36,4°C. Peso 61,8 kg, sem variação relevante face a controlo anterior. Sem exoftalmia, tremor distal ou mixedema. Pescoço sem adenopatias palpáveis; tiroide não aumentada, indolor, sem nódulo palpável.

TSH 1,86 mUI/L, T4L 1,18 ng/dL, compatíveis com eutiroidia sob substituição. Anti-TPO previamente positivos, 486 UI/mL, quadro compatível com tiroidite autoimune conhecida; sem utilidade em repetição seriada. Glicemia 89 mg/dL, creatinina 0,76 mg/dL, Na 140 mmol/L, K 4,2 mmol/L, cálcio 9,4 mg/dL. Hemograma sem alterações: Hb 13,1 g/dL, leucócitos $6,7 \times 10^9/L$, plaquetas $271 \times 10^9/L$.

Revista ecografia tiroideia de controlo: glândula de dimensões globais conservadas, ecotextura difusamente heterogénea e discretamente hipoecogénica, compatível com tiroidite crónica. Lobo direito com nódulo sólido subcentimétrico no terço médio, 6 x 4 x 5 mm, ovalado, margens regulares, mais largo que alto, sem microcalcificações ou focos ecogénicos suspeitos. Sem vascularização intranodular exuberante ao Doppler. Sem adenopatias cervicais suspeitas nas cadeias examinadas. Sem modificação dimensional ou morfológica comparativamente ao estudo anterior; nódulo de muito baixo risco, sem critérios para PAAF ou vigilância ecográfica dirigida.

Manter levotiroxina 50 mcg id. Reforçada toma em jejum, 30-60 min antes do pequeno-almoço; afastar suplementos de ferro/cálcio $\geq 4h$. Sem indicação para ajuste terapêutico. Reavaliar analiticamente TSH/T4L em 12 meses, ou mais cedo se sintomatologia/intercorrência clínica.

02-Dez-2025 Dr(a). Inês Valente (HUC-PNEUMOLOGIA)

AP: asma persistente moderada, rinite alérgica a ácaros. Hipotireoidismo autoimune sob substituição. Alergia a ibuprofeno, com broncospasmo prévio.

Reavaliação pós-exacerbação em SU em Novembro, após exposição marcada a pó/irritantes em contexto domiciliário. Quadro então com dispneia, pieira difusa, tosse seca e aumento de utilização de broncodilatador de alívio; sem febre, expectoração purulenta ou dor torácica. Cumpru corticoterapia sistémica curta prescrita em SU, sem intercorrências. Atualmente assintomática: sem dispneia em repouso ou esforço habitual, tosse, pieira, despertares nocturnos ou limitação laboral. Sem nova utilização de SABA nos últimos dias. Sem novas idas à urgência.

Processado por computador - SClinico



Diário Clínico

Consulta Externa

MH: budesonido/formoterol 200/6, 2 inalações 2id; montelucaste 10 mg à noite. Refere adesão globalmente adequada, embora previamente com algumas tomas omitidas em dias assintomáticos.

EO: bom estado geral, eupneica, sem tiragem. TA 118/72 mmHg, FC 76 bpm, SatO₂ 99% ar ambiente, T 36,4°C. ORL sem rinorreia activa; mucosa nasal discretamente pálida, sem secreções. AP com murmúrio vesicular mantido bilateralmente, sem sibilos, roncos ou crepitações; expiração não prolongada.

Espirometria realizada hoje: CVF 3,62 L, 101% previsto; VEMS 2,94 L, 98% previsto; VEMS/CVF 81%. Curva fluxo-volume sem concavidade expiratória significativa, sem padrão obstrutivo em condições basais. Após broncodilatador, VEMS 3,05 L, variação +110 mL/+3,7%, sem resposta broncodilatadora significativa. Comparativamente ao registo funcional de 2024, parâmetros ventilatórios estáveis, então VEMS 2,88 L/96% previsto. Rx tórax efectuada em contexto de SU, revista: campos pulmonares bem expandidos, sem condensações focais, sem sinais de hiperinsuflação relevante ou derrame pleural; silhueta cardíaca de dimensões conservadas. Sem evidência imagiológica de intercorrência infecciosa pulmonar.

Revista técnica inalatória com dispositivo pressurizado: inicialmente inspiração algo precoce face à activação; corrigida coordenação, expiração prévia, inspiração lenta/profunda e apneia final 8-10 seg. Reforçadas medidas de controlo ambiental: capas antiácaros impermeáveis em colchão/almofada, lavagem semanal de roupa de cama $\geq 60^{\circ}\text{C}$, redução de têxteis/acumulação de pó, aspiração com filtro adequado e ventilação regular, evitando aerossóis, fumo e produtos irritativos.

Asma actualmente controlada após exacerbação pontual alérgica/irritativa. Manter terapêutica de fundo sem escalada permanente. Budesonido/formoterol conforme prescrito; não suspender em períodos assintomáticos. Reavaliação em 6 meses com espirometria, ou antecipar se recorrência de sintomas, necessidade crescente de alívio ou nova exacerbação.

14-Fev-2026 Dr(a). Inês Valente (HUC-OTORRINOLARINGOLOGIA)

34 anos. Queixa-se de obstrução nasal crónica, flutuante, mais marcada à esquerda e em decúbito, sem agravamento recente. Sensação de passagem aérea reduzida sobretudo nocturna. Sem rinorreia purulenta, epistaxis, dor/facialgia, hiposmia persistente ou febre. Sem episódios recentes compatíveis com sinusite aguda. Rinite alérgica conhecida a ácaros, com espirros/prurido nasal ocasionais; sem crise asmática associada. Desvio septal previamente documentado.



Diário Clínico

Consulta Externa

EO: TA 112/70 mmHg, FC 76 bpm, SpO2 99% AA, T 36,4°C. Respiração oral ausente em repouso. Pirâmide nasal sem deformidade externa ou dor à palpação. Rinoscopia anterior: mucosa rosada, discretamente congestiva bilateralmente, sem crostas, secreções mucopurulentas ou lesões. Septo nasal com desvio ligeiro a moderado para a esquerda, predominante anterior, sem contacto significativo com corneto inferior; pequena redução do calibre da fossa nasal esquerda. Cornetos inferiores discretamente hipertróficos, com boa resposta à vasoconstricção tópica. Sem pólipos visíveis.

Endoscopia nasal flexível: vestibulo sem alterações, septo com desvio esquerdo já conhecido, sem perfuração ou esporão de relevo. Pavimento e meatos inferiores livres. Meatos médios permeáveis bilateralmente, sem edema marcado, pólipos, secreções ou massas. Recessos esfenotmoidais livres. Rinofaringe sem lesões; coanas permeáveis. Sem achados endoscópicos sugestivos de rinossinusite crónica activa ou patologia obstrutiva adicional.

Obstrução nasal de predomínio mecânico, associada a desvio septal ligeiro, com componente congestivo/rinítico discreto. Sem repercussão clínica que justifique septoplastia nesta fase. Lavagens nasais com soro fisiológico/isotónico 1-2x/dia, reforçar controlo ambiental para ácaros. Reavaliação se agravamento sustentado, sinusites recorrentes, epistaxis ou compromisso importante do sono.

10-Abr-2026 Dr(a). Inês Valente (HUC-NEUROLOGIA)

34A. Seguimento por enxaqueca com aura. AP: asma persistente moderada; tiroidite de Hashimoto sob substituição.

Refere boa resposta à profilaxia. Crises actualmente ~1/mês, habitualmente perimenstrual/stress, intensidade claramente inferior à prévia. Aura visual estereotipada, escotoma cintilhante/ondulações no hemisfério visual, instalação progressiva, duração 15-25 min, seguida de cefaleia hemcraniana pulsátil, foto-/fonofobia e náusea ocasional, sem vómitos. Sem modificação do padrão habitual, sem aumento de duração ou refractariedade.

Topiramato 50 mg 2id, boa adesão. Xerostomia ligeira/intermitente, tolerável; sem parestesias relevantes, perda ponderal marcada, alterações significativas do humor ou queixa cognitiva incapacitante. Sumatriptano 50 mg SOS com resposta adequada, habitualmente 1 cp/crise; sem necessidade de repetição frequente. Sem abuso de analgésicos/triptanos.

Nega cefaleia nova ou progressiva, despertar nocturno por cefaleia, agravamento com Valsalva/esforço, febre, rigidez cervical, síncope, crise com défice focal persistente, alteração da linguagem, diplopia, perda visual sustentada ou alteração do estado de



Diário Clínico

Consulta Externa

consciência. Sem gravidez planeada de imediato; reforçada necessidade de contacto prévio caso intenção gestacional, atendendo a topiramato.

EO: TA 112/70 mmHg, FC 72 bpm, SatO2 99% AA, T 36,5°C. Vigil, colaborante, linguagem fluente, discurso organizado. Pares cranianos sem alterações; campos visuais por confrontação sem defeito, pupilas isocóricas/fotorreactivas, motricidade ocular extrínseca íntegra. Sem défice motor, coordenação dedo-nariz e marcha normais. Sem rigidez meníngea.

Sem MCDT neurológico novo nesta consulta; perante estabilidade clínica e ausência de sinais de alarme, sem indicação actual para neuroimagem de controlo.

Enxaqueca com aura, bem controlada sob topiramato. Manter topiramato 50 mg 2id e sumatriptano 50 mg SOS, máximo 2 dias/semana e 9 dias/mês. Hidratação e medidas para xerostomia. Diário de crises. Reavaliação em 9-12 meses; antecipar se alteração do padrão, aumento de frequência ou sintomas neurológicos persistentes.

15-Jun-2026 Dr(a). Leonor Matos (HUC-ENDOCRINOLOGIA)

34A, seguimento anual por tiroidite crónica autoimune/hipotiroidismo. AP asma persistente moderada, enxaqueca com aura sob profilaxia. Sem queixas compatíveis com hipo/hipertiroidismo: nega astenia persistente, intolerância térmica, palpitações, tremor, obstipação, diarreia, alterações ponderais significativas, alterações menstruais ou queda de cabelo. Sem disfagia, disfonia, sensação de corpo estranho cervical ou dor cervical. Sem intercorrências desde última observação.

Mantém levotiroxina 50 mcg id, refere boa adesão. Toma habitualmente em jejum, com água, aguardando ~30 min até pequeno-almoço; sem toma concomitante de ferro, cálcio ou antiácidos. Sem gravidez planeada de momento; esclarecida necessidade de contacto precoce caso gravidez/planeamento gestacional, para reavaliação analítica e eventual ajuste posológico.

EO: bom estado geral, eupneica, corada, hidratada. TA 112/70 mmHg, FC 72 bpm, SpO2 99% AA, T 36,4°C, peso 61,8 kg, IMC 23,4 kg/m². Sem tremor distal, sem mixedema. Pescoço sem massas evidentes; tiroide não francamente aumentada, consistência discretamente firme, indolor, sem adenopatias cervicais palpáveis.

Analítica 08/06/2026: TSH 1,86 mUI/L, T4L 1,18 ng/dL, T3L 2,94 pg/mL. Hb 13,1 g/dL, leucócitos 6,7x10⁹/L, plaquetas 268x10⁹/L. Creatinina 0,74 mg/dL, Na 140 mmol/L, K 4,2 mmol/L, AST 18 U/L, ALT 16 U/L. Glicemia 86 mg/dL. Perfil compatível com eutiroideia sob dose actual; sem evidência analítica de sobre/substituição.



Diário Clínico

Consulta Externa

Ecografia tiroideia prévia revista: glândula de dimensões globais preservadas, ecotextura difusamente heterogénea e hipoecogénica, padrão pseudonodular compatível com tiroidite crónica. Lobo direito sem lesões focais suspeitas. No terço médio do lobo esquerdo, nódulo de 6 mm, ovalado, isoecogénico, margens regulares, sem microcalcificações ou vascularização central significativa. Sem adenopatias laterocervicais suspeitas. Mantém critérios ecográficos benignos, sem indicação para citologia.

Manter levotiroxina 50 mcg id. Reforçada toma em jejum e afastamento mínimo de 4 h de ferro/cálcio. Controlo TSH/T4L anual, ou mais cedo se sintomas, gravidez ou alteração ponderal relevante. Seguimento em Endocrinologia em 12 meses.

20-Jul-2026 Dr(a). Leonor Matos (HUC-PNEUMOLOGIA)

AP: asma persistente moderada, rinite alérgica a ácaros; hipotiroidismo autoimune sob substituição. Sem exacerbações, ciclos de corticoterapia sistémica, recurso a SU ou antibioterapia desde 11/2025. Nega dispneia de repouso, despertares nocturnos, tosse persistente, pieira ou limitação nas AVD. Episódios esporádicos de rinorreia/obstrução nasal em exposição a poeiras, sem repercussão brônquica recente. Sem tabagismo activo; sem exposição ocupacional relevante.

Mantém budesonido/formoterol 200/6, 2 inalações 2id, e montelucaste 10 mg à noite. Boa adesão referida; sem falhas regulares. Técnica inalatória revista: preparação correcta do dispositivo, expiração prévia, inspiração profunda e sustentada, apneia pós-inspiração adequada; sem erros relevantes. Não tem necessitado de broncodilatador de alívio nas últimas semanas. Evita AINEs, antecedente de broncospasmo com ibuprofeno.

EO: bom estado geral, eupneica, sem tosse durante observação. TA 118/74 mmHg, FC 72 bpm, SpO2 99% ar ambiente, T 36,4°C. Auscultação pulmonar com MV bilateralmente audível e simétrico, sem sibilos, roncos ou crepitações; expiração não prolongada. Sem sinais de dificuldade respiratória.

Espirometria de controlo realizada com manobras aceitáveis e reprodutíveis, qualidade técnica adequada. CVF 3,78 L, 101% do previsto; VEMS 3,05 L, 98% do previsto; índice VEMS/CVF 80,7%, dentro dos limites inferiores da normalidade para idade/sexo/estatura. Curva débito-volume sem concavidade expiratória significativa, sem evidência funcional de obstrução fixa. Pós-broncodilatação com VEMS 3,12 L, variação +70 mL/+2%, não significativa; CVF 3,81 L. Comparativamente à espirometria de 07/2025, VEMS previamente 3,00 L e CVF 3,74 L, sem variação significativa, traduzindo estabilidade funcional. Sem critérios espirométricos de reversibilidade significativa no momento, compatível com doença controlada sob terapêutica de manutenção.



Diário Clínico

Consulta Externa

Asma clinicamente controlada, função respiratória estável. Manter esquema actual, reforçadas medidas de evicção alergénica e adesão. Reavaliar em 12 meses com espirometria, ou antecipadamente se aumento de sintomas/necessidade de medicação de alívio.